2024年 秋
医療安全・事業継続推進協議会

命と現場を守る「設計図」

医療福祉現場におけるISO 31000 / ISO 22301 実践ガイド

NotebookLM

「絶対に止めてはいけない」現場を襲う、想定外の連続

- 命を預かる医療・福祉機関は、地域社会の最重要インフラ。
- しかし、災害、感染症の長期化、サイバー攻撃によるシステム障害など、多様なリスクに常に晒されている。
- 現状の属人的な努力や「気合い」だけでは、限界を迎えつつある。

「医療機能をいかに途切れさせずに維持するか」が、
すべての病院・クリニックの共通課題。

NotebookLM

課題の核心：「書類上のBCP」が抱える致命的な弱点

現状：　多くの福祉法人や自治体で「書類上のBCP」は作成済み。

問題点：
- 実際の急変対応フローが弱い。
- 臨床視点（医療従事者のリアルな動き）が欠落している。
- 平時の訓練が不足し、いざという時に誰も動けない。

> 「マニュアルはあるが、災害時に読んでいる暇はない。
> 実務プロセスが伴っていない計画は機能しない。」

NotebookLM

組織と命を守る、世界標準の「設計図」

属人的な管理から脱却し、「実働する体制」を構築するための2つの国際規格。

ISO 31000 : リスクマネジメント。あらゆる脅威を事前に察知し、最適化する枠組み。

ISO 22301 : 事業継続マネジメントシステム (BCMS)。「止まる前提」で、どう最小被害で回し続けるかを定めた計画と訓練の仕組み。

NotebookLM

ISO 31000とは？ ＝「組織の予防医療」

患者の小さな異変から重篤な疾患を予測するように、
組織に潜むリスクを特定・評価するプロセス。

1. 診察（リスクの特定）：
日常業務に潜む「ヒヤリハット」や脆弱性の洗い出し。

2. 精密検査（リスクの分析・評価）：
発生確率と影響度の測定（人間的・文化的要因の考慮）。

3. 処方・治療（リスク対応）：
事故を未然に防ぐための業務フロー改善と安全対策。

管理からマネジメントへ。ネガティブな影響を減らし、安全文化を醸成する。

NotebookLM

ISO 22301とは？ ＝「組織の救命救急（BCMS）」

災害やシステム障害で「心肺停止」に陥った際、
どの機能を優先して蘇生させるかを取り決める
「トリアージと救命処置」のルール。

BIA（事業影響分析）

「絶対に止められない業務（救急、透析など）」の優先順位付け。

RTO（復旧目標時間）

いつまでにその業務を再開させるか（例：何時間以内に電源を復旧するか）。

代替手段の確保

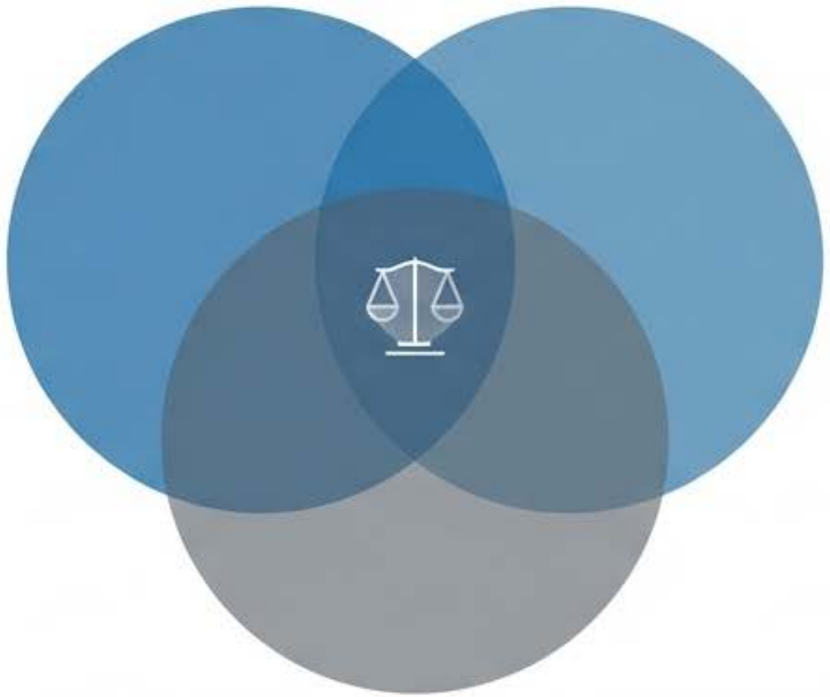
ITダウン時の「紙カルテ運用」など、バックアップの設計。

「止まらないこと」ではなく、「止まる前提で、どう最小被害で回し続けるか」の設計図。

NotebookLM

なぜ今、医療・福祉現場にISOが必要なのか？

患者の安全確保: 医療事故・ヒヤリハットの統計的削減と、災害時の適切なケア体制の維持。



職員の保護と労働環境改善: 業務プロセスの可視化による負担軽減。不明瞭な指示によるストレスと属人化の解消。

経営の安定と信頼向上: 法規制遵守の強化、地域社会・患者からの信頼獲得、およびコスト削減（無駄なプロセスの排除）。

NotebookLM

パラダイムシフト：「臨床の知見」がISOを完成させる

- ISO規格は単なる枠組み（箱）に過ぎない。
- その箱に命を吹き込むのは、現場で培われた「医療従事者の経験とスキル」。
- 規格を上から押し付けるのではなく、現場のエキスパートがISOを「道具」として使いこなすことで、初めて実働するシステムになる。

→ 臨床スキルをISOにどう実装するか

NotebookLM

実践例① リスクの特定 × 「看護師18年の臨床の目」

ISOが求めること:	組織内の潜在的な脆弱性の発見。
現場のスキル:	長年の経験に基づく「ヒヤリハットの嗅覚」。多忙な業務フローの中に潜む「穴」を五感で察知する能力。
融合の成果:	チェックリストの表面的な確認を超えた、現場の実態に即した文脈依存的なリスク評価が可能に。 属人化された暗黙知を標準業務手順書(SOP)へと昇華。

NotebookLM

実践例② リスクの分析・評価 ×「心電図判読スキル」

ISOが求めること:	精密なデータ分析とモニタリング。微小な兆候からの異常検知。
現場のスキル:	12誘導心電図の微細な波形変化から、致死的な不整脈を予見する能力（心電図検定1級相当の精密な分析力）。
融合の成果:	医療DXやシステムから出力される「微細なデータ異常（アノマリー）」から、重大なシステム不全やインシデントを未然に察知する論理的思考力へ直結。

NotebookLM

実践例③ レジリエンスと訓練 ×「ACLSインストラクター」

ISOが求めること:	実働する事業継続訓練と、組織のレジリエンス（回復力）の向上。
現場のスキル:	極限状態でのチーム統率、シミュレーション教育、および「デブリーフィング（振り返り）」の技術。
融合の成果:	「形だけの防災訓練」から脱却。特定の専門職が不在、または機器が故障したシナリオでの「実働するBCP訓練」を設計し、組織のPDCAサイクルを回す原動力となる。

NotebookLM

医療DXの推進と、新たなリスクへの防衛線

- 電子カルテの普及、オンライン診療、AI診断支援など、医療のIT化は不可避。
- 一方で、ランサムウェア攻撃や停電による「システム停止」は、即座に診療停止を意味する致命的リスク。
- ISOの役割: システム障害時の「代替運用（紙カルテへの切り替えフロー等）」を事前に設計し、情報の保護と医療の継続を両立させる。

現場の臨床感覚を持つ「デジタル・セーフティ・オフィサー」の存在が、安全なDX推進の鍵を握る。

NotebookLM

組織文化の変革：「やらされ仕事」から「実働」へ

Before (Current State)

- 書類審査のためだけのマニュアル作成。
- 「監査をやり過ごす」ことが目的。
- 現場に負担を強いるだけのルール。

After (ISO Integrated Culture)

- 命と現場を守るための「道具」としての活用。
- インシデントから学習し、システムを継続改善（PDCA）。
- 個人の過失を責めず、組織の仕組みを直す「安全文化」の定着。

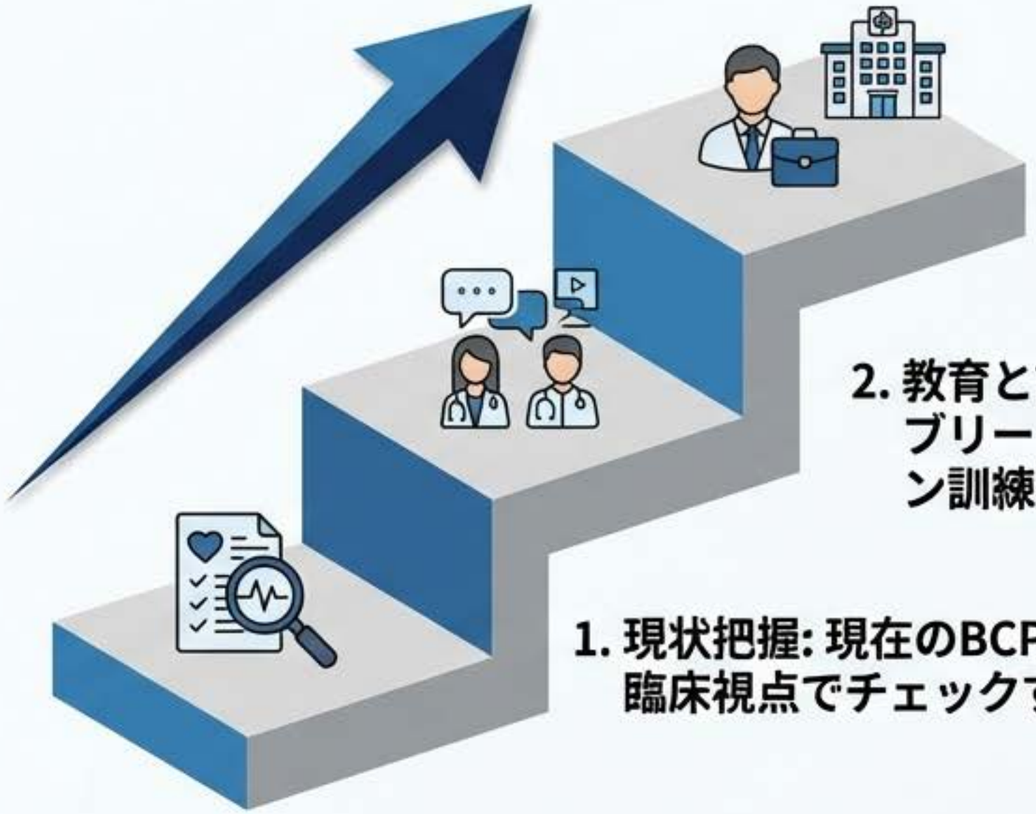
NotebookLM

サマリー：ISOは認証取得が目的ではない

- ISO 31000 & 22301 は、医療機関が直面する不確実性に立ち向かうための「グローバルな共通言語」。
- 最も重要なのは、現場が持つ尊い「臨床スキルと経験」を、組織全体のマネジメントに拡張すること。
- ルールに縛られるのではなく、ルールを使いこなし、「揺るぎない安全と信頼」を築く。

NotebookLM

次のステップ：強靭な医療体制の構築に向けて



3. 専門家の活用: 内部監査や体制構築において、臨床現場を知るコンサルタントやISO審査員の知見を取り入れる。

2. 教育と訓練: 形だけの防災訓練を見直し、デブリーフィングを取り入れたシミュレーション訓練を計画する。

1. 現状把握: 現在のBCP（事業継続計画）が「実働可能」か、臨床視点でチェックする。（BIA：事業影響分析の実施）

医療機関向けBCP・BIA診断用
チェックリストをダウンロード

NotebookLM